

Licencjat z pielęgniarstwa

kompedium wiedzy i praktyki

Jak napisać pracę licencjacką z pielęgniarstwa

PRACA KAZUISTYCZNA...

Czytelnik zrozumie, dlaczego praca licencjacka...

ANATOMIA PRACY...

Czytelnik pozna dokładną budowę każdego rozdziału pracy...

EGZAMIN DYPLOMOWY...

Czytelnik dowie się, jak praca licencjacka wpisuje się...

35+

KOMPLETNY PRZEWODNIK

2026

Spis treści

1. Praca kazuistyczna w pielęgniarstwie – czym różni się od innych kierunków i dlaczego to ma znaczenie	3
1.1. Kazuistyka zamiast badań ankietowych – wymóg prawny i zawodowy, nie tradycja	3
1.2. Jak wybrać przypadek, który dostanie ocenę bardzo dobrą – kryteria promotora i recenzenta w liczbach	5
1.3. Harmonogram 6-semesteralny – kamienie milowe, terminy formalne i punkty krytyczne	8
2. Anatomia pracy licencjackiej z pielęgniarstwa – każdy element pod lupą	11
2.1. Od wstępu do metodologii – jak napisać część teoretyczną, która nie jest encyklopedią choroby	11
2.1.1. Wstęp – wprowadzenie, nie streszczenie	12
2.1.2. Przegląd piśmiennictwa – struktura kliniczna, nie encyklopedia	12
2.1.3. Rozdział metodologiczny – precyzja, nie biurokracja	13
2.1.4. Wybór i sformułowanie tematu – jak nie zacząć od błędu	14
2.2. Opis przypadku i diagnoza pielęgniarstwa – jak zebrać dane i przełożyć je na plan opieki	15
2.2.1. Wywiad pielęgniarstwa – co zbierać i w jakiej kolejności	15
2.2.2. Skale kliniczne – narzędzia, które legitymizują ocenę	16
2.2.3. Od danych do diagnozy pielęgniarstwa – logika, nie intuicja	16
2.2.4. Plan opieki pielęgniarstwa – tabela, która musi działać	17
2.3. Podsumowanie, streszczenia i aneks – elementy, które decydują o końcowej ocenie redakcyjnej	18
2.3.1. Podsumowanie – wnioski, nie streszczenie	18
2.3.2. Streszczenia – dwa języki, jeden standard	19
2.3.3. Aneks – dokumentacja, nie śmietnik	19
2.3.4. Różnice między uczelniami – praktyczny przegląd	20
2.3.5. Piśmiennictwo – format, który musi być bez zarzutu	21
2.3.6. Spisy tabel, rycin i fotografii – porządek formalny	22
2.3.7. Oświadczenia i strona tytułowa – formalności z konsekwencjami	22
3. Egzamin dyplomowy z pielęgniarstwa – obrona pracy, test MCQ i OSCE jako system naczyń połączonych	25

3.1. Test MCQ – 100 pytań, 13 dziedzin, 60% próg zaliczenia: co musisz wiedzieć przed salą egzaminacyjną	26
3.2. Obrona pracy przed komisją – prezentacja, pytania promotora i recenzenta, pytania kierunkowe	27
3.2.1. Faza pierwsza: prezentacja	28
3.2.2. Faza druga: pytania do pracy	28
3.2.3. Faza trzecia: pytania kierunkowe	29
3.3. Egzamin OSCE w Centrum Symulacji – jak temat pracy przekłada się na umiejętności praktyczne oceniane na stacjach	30
3.4. Zakończenie: trzy egzaminy, jeden cel	31

Rozdział 1.

Praca kazuistyczna w pielęgniarstwie – czym różni się od innych kierunków i dlaczego to ma znaczenie

Pielęgniarstwo to zawód, w którym wiedza teoretyczna ma wartość wyłącznie wtedy, gdy przekłada się na konkretne działanie przy łóżku pacjenta. Praca licencjacka powinna to udowodnić.

Zanim napiszesz pierwsze zdanie pracy licencjackiej, musisz zrozumieć jedną zasadniczą kwestię: forma tej pracy nie jest sprawą gustu ani tradycji akademickiej. Jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i ze specyfiki zawodu regulowanego. Student pielęgniarstwa nie ma wyboru między sondażem diagnostycznym a studium przypadku w taki sposób, jak ma go student socjologii czy zarządzania. Kazuistyka jest tu jedyną dopuszczalną metodą – i dobrze rozumiana, staje się narzędziem, które pozwala naprawdę zademonstrować gotowość do samodzielnej praktyki klinicznej.

1.1 Kazuistyka zamiast badań ankietowych – wymóg prawny i zawodowy, nie tradycja

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1332), ustanawia ramy, w których promotorem pracy licencjackiej może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. To nie jest przypadkowy zapis. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że dyplomowanie na pielęgniarstwie ma być oceniane przez praktyków, a nie wyłącznie przez metodologów nauk społecznych.

Praca kazuistyczna

Praca dyplomowa oparta na metodzie studium indywidualnego przypadku (ang. *case study*), w której student analizuje sytuację zdrowotną, pielęgnacyjną i psychospołeczną jednego pacjenta, buduje diagnozę pielęgniarstwa i planuje oraz ocenia opiekę.

Regulaminy dyplomowania wiodących uczelni medycznych precyzują ten wymóg bez wyjątków. Regulamin Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022 wprost stanowi: *praca dyplomowa ma charakter kazuistyczny/studium przypadku*. Zaktualizowany regulamin z roku akademickiego 2025/2026 – obowiązujący na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW – zachowuje to samo brzmienie i uzupełnia je o możliwość złożenia artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie indeksowanym w Web of Science lub Scopus, jednak wyłącznie jako alternatywę dla studentów, którzy w trakcie studiów taki artykuł przygotowali i opublikowali. Dla zdecydowanej większości studentów obowiązuje więc jedna forma: opis przypadku z pełnym procesem pielęgnowania.

Zasady pisania pracy licencjackiej na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku potwierdzają tę regułę bez żadnych wyjątków i dodają konkretne parametry techniczne: objętość do 30 stron maszynopisu w formacie A4, minimum 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 10 lat, formatowanie zgodne ze standardem Vancouver. Warszawski Uniwersytet Medyczny w swoich materiałach informacyjnych dla studentów precyzuje, że optymalna objętość samego opisu pacjenta to 2–3 strony, a cały przegląd piśmiennictwa nie powinien przekraczać jednej trzeciej całej pracy.

Dlaczego właśnie studium przypadku, a nie sondaż diagnostyczny z setką respondentów? Powód jest merytoryczny, nie estetyczny. Pielęgniarka w pracy zawodowej nie zarządza statystykami populacyjnymi – ona sprawuje opiekę nad konkretnym, неповtarzalnym człowiekiem. Proces pielęgnowania, który stanowi metodologiczny fundament tej pracy, wymaga sekwencyjnego myślenia klinicznego: zebrania danych, postawienia diagnozy pielęgniarstwa, sformułowania celu, zaplanowania interwencji, ich realizacji i oceny wyników. Żadna ankieta z zamkniętymi odpowiedziami nie jest w stanie pokazać, czy student potrafi wykonać każdy z tych kroków.

Pułapka sondażu – błąd, który zdarza się na etapie wyboru tematu

Część studentów, przyzwyczajona do form pracy stosowanych na innych kierunkach, próbuje zaproponować promotorowi temat oparty na badaniu ankietowym, np. „Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki odleżyn”. Promotor taki temat odrzuci albo zmusi do gruntownego przekształcenia. Praca licencjacka z pielęgniarstwa **musi** zawierać indywidualny opis przypadku pacjenta wraz z procesem pielęgnowania – to wymóg formalny, nie preferencja prowadzącego.

Sondaż diagnostyczny mógłby sprawdzić, ile student wie o pewnym zagadnieniu. Studium przypadku sprawdza, czy potrafi tę wiedzę zastosować. Różnica jest precyzyjnie zdefiniowana w regulaminie UMW z 2025/2026: praca dyplomowa ma wskazywać na umiejętność objęcia

pacjenta całościową opieką, diagnozowania problemów i potrzeb, opracowania planu opieki dostosowanego do wcześniej ustalonego stanu pacjenta, a także oceny i weryfikacji podjętych działań. To jest lista kompetencji zawodowych, nie lista tematów do opanowania. Egzamin dyplomowy – z jego częścią testową MCQ obejmującą 100 pytań z 13 obszarów specjalistycznych oraz praktyczną częścią OSCE w Centrum Symulacji Medycznej – sprawdza wiedzę i umiejętności proceduralne. Praca licencjacka sprawdza coś innego: zdolność do klinicznego myślenia o całości opieki nad człowiekiem.

Warto też rozumieć, czego komisja egzaminacyjna oczekuje podczas obrony. Regulamin UMW z 2025/2026 precyzuje, że student prezentuje najważniejsze elementy pracy, odpowiada na pytania dotyczące tej pracy, a następnie odpowiada na pytania z zakresu kierunku pielęgniarstwo – w sumie trzy pytania warte 30 punktów łącznie. Praca kazuistyczna dobrze napisana staje się podczas obrony naturalnym punktem wyjścia do rozmowy o klinice, farmakologii, etyce zawodowej i organizacji opieki. Praca ankietowa takiej podstawy nie daje.

Kazuistyka jako weryfikacja gotowości zawodowej

Studium przypadku to jedyna metoda, która pozwala sprawdzić jednocześnie: wiedzę kliniczną, umiejętności diagnostyczne, planowanie opieki i ocenę działań. Rozporządzenie MNiSW z 2016 r. i regulaminy uczelni medycznych nie dopuszczają alternatywy – to wymóg prawny wynikający ze standardów kształcenia zawodowego.

1.2 Jak wybrać przypadek, który dostanie ocenę bardzo dobrą – kryteria promotora i recenzenta w liczbach

39

punktów to maksimum, jakie może przyznać promotor – każde kryterium warte jest 0–3 punkty

Regulamin dyplomowania UMW, zarówno w wersji z 2021/2022, jak i zaktualizowanej z 2025/2026, zawiera identyczną siatkę ocen. Promotor ocenia pracę w 13 kryteriach, każde punktowane w skali 0–3 (0 – brak, 1 – poprawne, 2 – dobre, 3 – bardzo dobre). Maksimum to 39 punktów. Recenzent ocenia 12 kryteriów w tej samej skali – maksimum 36 punktów. Ocena bardzo dobra (5,0) u promotora wymaga uzyskania 37–39 punktów; u recenzenta – 33–36 punktów. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich kryteriów wraz z tym, które z nich studenci najczęściej zaniedbują.

Patrząc na tę siatkę od strony strategicznej, można wyodrębnić cztery kryteria, które studenci systematycznie niedoszacowują, tracąc punkty nie dlatego, że nie znają pielęgniarstwa, lecz dlatego, że nie rozumieją, czego dana rubryka dotyczy.

Tabela 1.1: Kryteria oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta (Regulamin UMW 2025/2026)

Kryterium	Dotyczy	Promotor	Recenzent
Sformułowanie przedmiotu i problemu badawczego	Oba	0–3	0–3
Sformułowanie celu (celów) pracy	Oba	0–3	0–3
Wykorzystanie metod i technik badawczych	Oba	0–3	0–3
Zdefiniowanie problemów w oparciu o diagnozę pielęgniarską	Oba	0–3	0–3
Hierarchia problemów zdrowotnych/pielęgnacyjnych	Oba	0–3	0–3
Zasadność wskazanych do rozwiązania problemów	Oba	0–3	0–3
Dobór wykorzystanej literatury	Oba	0–3	0–3
Dobór i zakres źródeł danych empirycznych	Oba	0–3	0–3
Trafność wnioskowania – zalecenia dla praktyki	Oba	0–3	0–3
Poprawność stylistyczna i gramatyczna	Oba	0–3	0–3
Redakcja przypisów i załączników	Oba	0–3	0–3
Poprawność spisów treści, literatury, prezentacji danych	Oba	0–3	0–3
Zaangażowanie i wkład pracy studenta	Tylko promotor	0–3	—

Hierarchia problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. To kryterium sprawdza, czy student potrafi uszeregować problemy pacjenta według ich pilności i znaczenia klinicznego – nie alfabetycznie ani chronologicznie, lecz zgodnie z logiką zagrożenia życia i zdrowia. Błąd polega na tym, że wielu studentów wymienia problemy w kolejności, w jakiej przyszły im do głowy podczas zbierania wywiadu. Tymczasem komisja oczekuje hierarchii: najpierw problemy zagrażające życiu lub wymagające natychmiastowej interwencji, następnie problemy istotne klinicznie, na końcu deficyty edukacyjne i społeczne.

Trafność wnioskowania jako zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej. To kryterium jest często traktowane jako formalne podsumowanie pracy – kilka zdań, że „opieka była właściwa”. Komisja oczekuje czegoś innego: konkretnych, operacyjnych wskazówek dla praktykujących pielęgniarek, wynikających bezpośrednio z analizowanego przypadku. Dobrze sformułowane wnioski odpowiadają na pytanie: co ta praca wnosi do praktyki klinicznej ponad to, co już wiemy z podręczników?

Dobór i zakres źródeł danych empirycznych. To kryterium dotyczy sposobu zebrania informacji o pacjencie – wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji medycznej, pomiarów parametrów życiowych, zastosowanych skal klinicznych. Studenci, którzy ograniczają się wyłącznie do historii choroby i wywiadu słownego, tracą tu punkty. Regulamin UMW i wytyczne WUM wskazują na

szeroki wachlarz technik: skale Barthel, ADL, NRS do oceny bólu, GCS do oceny neurologicznej – każda zastosowana i uzasadniona merytorycznie podnosi ocenę.

Sformułowanie problemu badawczego. Wielu studentów myli problem badawczy z tematem pracy. Temat to: „Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”. Problem badawczy to pytanie, na które praca ma odpowiedzieć, np. „Jakie problemy pielęgnacyjne w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej występują u 68-letniego pacjenta z zaostrzeniem POChP hospitalizowanego w oddziale chorób wewnętrznych, i jak zaplanowana opieka pielęgniarska wpłynęła na ich redukcję?”. Różnica jest jakościowa – i komisja ją widzi od pierwszej strony pracy.

Jak wybrać przypadek pod kątem siatki ocen

Wybierając przypadek do pracy, zadaj sobie pytanie: czy ten pacjent pozwoli mi zaprezentować co najmniej 5–7 zróżnicowanych, hierarchicznie uszeregowanych problemów pielęgnacyjnych? Jeśli przypadek jest zbyt prosty (np. pacjent z niepowikłanym złamaniem kości promieniowej w znieczuleniu miejscowym), nie dasz rady zaprezentować diagnozy pielęgnarskiej w pełnym wymiarze. Wybieraj przypadki z kilkoma obszarami opieki: biologicznym, psychicznym i społecznym – to jedyna droga do 3 punktów za hierarchię i zasadność problemów.

Wybór tematu i przypadku ma bezpośrednie przełożenie na to, ile punktów zdobędziesz. Regulamin UMW wskazuje, że praca powinna dotyczyć opieki nad pacjentem w różnych okresach życia i stanach zdrowia, uwzględniając promocję zdrowia. Oznacza to, że przypadek ograniczony wyłącznie do procedur szpitalnych, bez elementu edukacji pacjenta lub oceny środowiska domowego, automatycznie zawęży zakres diagnozy pielęgnarskiej i obniża ocenę w kryterium zasadności problemów.

Materiały informacyjne WUM dla studentów precyzują dodatkowo: wśród funkcji zawodowych, które praca powinna demonstrować, jest funkcja opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna i koordynacyjna. Przypadek pacjenta, który umożliwi zademonstrowanie wszystkich czterech, jest przypadkiem wartym oceny bardzo dobrej. Przypadek, który pozwala pokazać tylko funkcję opiekuńczą, daje ocenę co najwyżej dobrą.

Przypadek pod kątem kryteriów – dwa tematy, dwa wyniki

Wyobraź sobie dwie studentki, obie opisujące pacjenta po zawale mięśnia sercowego. Pierwsza skupia się wyłącznie na fazie ostrej: monitorowaniu EKG, podawaniu tlenu, obserwacji parametrów hemodynamicznych. Diagnozuje 3 problemy, wszystkie biologiczne. Wnioski: „Opieka pielęgnarska po zawale wymaga stałego monitorowania stanu pacjenta”. Druga opisuje tego samego pacjenta w fazie subostrej i przygotowania do wypisu: włącza lęk o powrót do pracy, deficyt wiedzy w zakresie diety i aktywności fizycznej, problemy z samoopieką w środowisku domowym. Diagnozuje 7 problemów w hierarchii. Wnioski zawierają konkretny program edukacyjny dla pacjenta i zalecenia

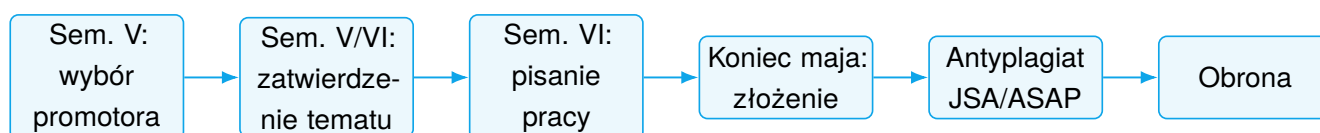
dla pielęgniarki POZ. Pierwsza praca dostanie u promotora 28–30 punktów. Druga – 36–39 punktów. Różnicę tworzy nie wiedza o zawale, lecz zakres zastosowanego procesu pielęgnowania.

Siatka ocen jako mapa pisania

Zanim zaczniesz pisać, wydrukuj 13-kryterialną siatkę ocen z regulaminu swojej uczelni i traktuj ją jak listę kontrolną. Każde kryterium to osobna decyzja, którą podejmujesz na etapie wyboru tematu, przypadku i struktury pracy. Punkty tracone na hierarchii problemów i na trafności wniosków można odrobić wyłącznie przez świadome zaplanowanie całości – nie przez korektę w ostatniej chwili.

1.3 Harmonogram 6-semestralny – kamienie milowe, terminy formalne i punkty krytyczne

Studia licencjackie na pielęgniarstwie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem co najmniej 180 punktów ECTS, w tym minimum 1200 godzin praktyk zawodowych wartych 30 punktów ECTS. W tym kontekście pisanie pracy licencjackiej nie jest projektem realizowanym na końcu – jest procesem, który formalnie zaczyna się w semestrze V i trwa do obrony. Studenci, którzy o tym zapominają, wpadają w pośpiech o złych konsekwencjach: promotorzy nie akceptują prac pisanych w ciągu trzech tygodni, a systemy antyplagiatowe nie przebaczą kompilowanych w panice tekstów.



Semestr V – wybór promotora i ustalenie tematu. Regulamin WUM precyzuje termin wyboru tematu: semestr V, nie później niż do końca roku kalendarzowego danego roku akademickiego. Regulamin UMW z 2025/2026 formułuje to jako „najpóźniej pod koniec przedostatniego semestru studiów”. W praktyce oznacza to, że w 9. – 10. tygodniu semestru V powinieneś mieć promotora i zaakceptowany temat. Jeśli nie dokonasz wyboru w terminie, dziekan wyznaczy ci promotora z urzędu – bez gwarancji, że będzie to osoba specjalizująca się w obszarze, który cię interesuje.

Wybór promotora to decyzja strategiczna. Promotorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki z co najmniej tytułem magistra i prawem wykonywania zawodu pielęgniarki. To oznacza, że pula promotorów jest ograniczona i na popularnych specjalizacjach – kardiologia, onkologia, geriatra – lista chętnych zamyka się szybko. Regulamin UMW z 2025/2026 przewiduje nawet sytuację rezygnacji promotora z powodu braku postępów studenta, którą promotor może złożyć

nie później niż do końca przedostatniego semestru. Innymi słowy: brak kontaktu i brak postępów ma formalne konsekwencje, nie tylko interpersonalne.

Zatwierdzenie tematu przez Prodziekana. W WUM temat zatwierdza Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Oddziału Pielęgniarstwa. Procedura wymaga złożenia wniosku w sekretariacie zakładu, w którym pracuje promotor. Błąd, który powoduje tygodniowe opóźnienia: studenci składają wniosek bezpośrednio do dziekanatu, z pominięciem sekretariatu zakładu. Formularz wniosku o zatwierdzenie tematu jest ściśle określony zarządzeniem rektora i nie można go zastąpić nieformalną wiadomością e-mail.

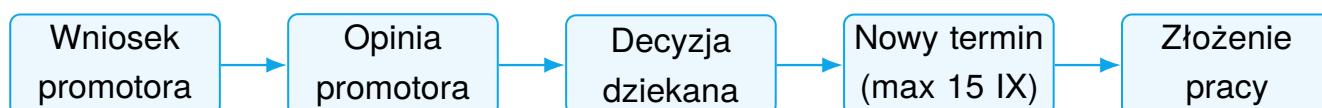
Komisja Bioetyczna – wymóg często pomijany

Jeśli twój projekt badawczy wymaga zbierania danych od pacjentów lub dostępu do dokumentacji medycznej w sposób wykraczający poza standardowy wywiad dla potrzeb studium przypadku, promotor ma obowiązek uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej. Regulamin UMW z 2021/2022 wskazuje Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Postępowanie komisji trwa zwykle 4–8 tygodni. Jeśli promotor zorientuje się o tym wymogu w grudniu semestru V, a ty chcesz złożyć pracę w maju semestru VI, możesz mieć poważny problem z harmonogramem. Ustal z promotorem na pierwszym spotkaniu, czy twój projekt wymaga opinii bioetycznej.

Semestr VI – pisanie pracy i konsultacje z promotorem. WUM przydziela formalnie 10 godzin konsultacji na każdą pracę, z czego student ma odbyć około 5 spotkań. Konsultacje są obowiązkowe i mają swój harmonogram potwierdzany w dokumentacji zakładu. To nie jest formalność – każda konsultacja to kontrolny punkt postępu, po którym promotor może odmówić dalszego prowadzenia pracy, jeśli student nie realizuje ustalonych poprawek.

Praca powinna osiągnąć objętość 25–40 stron maszynopisu (WUM) lub do 30 stron (UMB) przed złożeniem. Przy interlinii 1,5 i czcionce 12 pkt daje to realnie 6500–10 000 słów tekstu merytorycznego. Studenci, którzy próbują napisać pracę w ciągu dwóch tygodni, produkują objętość, ale nie jakość – i traci na tym przede wszystkim kryterium trafności wnioskowania oraz hierarchii problemów, bo nie ma czasu na rewizję struktury diagnozy.

Termin złożenia pracy – koniec maja semestru VI. WUM formułuje ten termin precyzyjnie: najpóźniej do końca maja VI semestru. Regulamin UMW z 2025/2026 dopuszcza przedłużenie do 15 września danego roku akademickiego, ale wyłącznie na uzasadniony wniosek zaopiniowany przez promotora i zatwierdzony przez dziekana. Niezłożenie pracy w terminie bez takiej zgody skutkuje skreśleniem z listy studentów – nie warunkowym zaliczeniem, lecz skreśleniem.



Procedura antyplagiatowa JSA i ASAP. Tekst pracy przechodzi przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) w przypadku UMB lub przez Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) w przypadku UMW. Pozytywny wynik weryfikacji jest formalnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Regulamin UMW z 2025/2026 precyzuje, że raport podobieństwa jest generowany dla każdej sprawdzanej pracy, a w przypadku uznania pracy za plagiat rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

Co powoduje wysoki wskaźnik podobieństwa? Nie tylko skopiowane fragmenty, ale też nadmierne cytowanie podręczników w cudzysłowie zamiast parafrazy, kopiowanie gotowych tabel i klasyfikacji bez przetworzenia, a także powielanie schematycznych sformułowań charakterystycznych dla opisów pielęgniarских. UMB wprost wskazuje, że cytowanie podręczników należy ograniczyć do niezbędnego minimum i zastępować je artykułami z czasopism naukowych.

Zarządzanie harmonogramem – trzy daty, których nie wolno przegapić

Wpisz do kalendarza trzy terminy nieprzekraczalne: (1) koniec semestru V – ostateczny termin złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu; (2) połowa semestru VI (typowo marzec) – termin złożenia pełnego draftu rozdziału teoretycznego i opisu przypadku u promotora; (3) koniec maja semestru VI – złożenie gotowej pracy w dziekanacie z wymaganymi dokumentami. Każde opóźnienie w punkcie (1) kompresuje czas na punkty (2) i (3), co bezpośrednio obniża jakość pracy i ocenę.

Forma złożenia pracy. WUM wymaga złożenia dwóch egzemplarzy w różnych oprawach (miękka i twarda) oraz wersji elektronicznej na płycie CD. UMB wymaga wydruku jednostronnego na białym papierze A4 z okładką sztywną. UMW wymaga pliku w formacie DOC lub DOCX oraz PDF na nośniku elektronicznym, przy czym tekst wydrukowany i elektroniczny muszą być identyczne – student potwierdza to pisemnym oświadczeniem. Niezgodność między wersją papierową a elektroniczną to błąd formalny, który może opóźnić dopuszczenie do obrony.

Harmonogram jako projekt, nie jako lista zadań

Pisanie pracy licencjackiej z pielęgniarstwa to projekt trwający minimum 12–14 miesięcy, z czterema formalnymi punktami kontrolnymi: wyborem promotora, zatwierdzeniem tematu, złożeniem pracy i procedurą antyplagiatową. Każdy z tych punktów ma termin wynikający z regulaminu – nie z uprzejmości dziekanatu. Studenci, którzy traktują pisanie pracy jak zadanie semestralne, tracą czas, który przekłada się bezpośrednio na jakość diagnozy pielęgniarskiej i ostateczną ocenę.

Rozdział 2.

Anatomia pracy licencjackiej z pielęgniarstwa – każdy element pod lupą

Praca licencjacka z pielęgniarstwa to nie esej o chorobie. To udokumentowany dowód, że potrafisz myśleć klinicznie o konkretnym człowieku – i przekuć to myślenie w zorganizowany plan działania.

Wielu studentów przystępuje do pisania pracy z błędnym założeniem: że im więcej wiedzą o jednostce chorobowej, tym lepsza będzie praca. W efekcie rozdziały teoretyczne rozrastają się do 20 stron szczegółowego opisu patofizjologii, a opis samego pacjenta – czyli serce całej pracy kazuistycznej – liczy trzy akapity. Promotorzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są co do tego zgodni: przegląd piśmiennictwa ma stanowić nie więcej niż jedną trzecią całej pracy. Przy 30 stronach to maksymalnie 10 stron na teorię. Reszta należy do pacjenta i opieki.

Ten rozdział rozkłada każdy element pracy na czynniki pierwsze – od wstępu aż po aneks – i wskazuje, gdzie studenci tracą punkty, które można zachować przy odrobinie dyscypliny redakcyjnej.

2.1 Od wstępu do metodologii – jak napisać część teoretyczną, która nie jest encyklopedią choroby

Najczęstszy błąd w rozdziale teoretycznym nie polega na tym, że student pisze za mało. Polega na tym, że pisze o złych rzeczach. Patogeneza choroby, kaskada biochemiczna, szczegółowy opis receptorów – to treści, które należą do podręcznika fizjologii, nie do pracy licencjackiej z pielęgniarstwa. Recenzent nie pyta o mechanizm molekularny; pyta, co pielęgniarka robi z tym pacjentem.

2.1.1 Wstęp – wprowadzenie, nie streszczenie

Wstęp pełni jedną funkcję: przygotowuje czytelnika do lektury właściwej pracy. Powinien zawierać krótki zarys jednostki chorobowej stanowiącej temat pracy, wskazanie roli pielęgniarki w opiece nad takim pacjentem, uzasadnienie wyboru tematu oraz odesłanie do celu pracy. WUM wymaga, by wstęp nawiązywał do co najmniej dwóch badań z wybranego zakresu – to konkretny wymóg, który należy spełnić.

Objętość wstępu to jedna do kilku stron – żadna z wiodących uczelni nie pozwala, by przekroczył jedną trzecią całej pracy. Przy 30-stronicowej pracy (wymóg UMB) to granica 10 stron dla całej części teoretycznej razem wziętej; wstęp powinien zamknąć się na 1–2 stronach.

Wstęp to nie miejsce na podsumowanie rozdziałów

Wielu studentów pisze wstęp jako spis treści przebrany w zdania: „W rozdziale pierwszym omówiono definicję, w rozdziale drugim epidemiologię...” – i powtarza to samo w zakończeniu. Wstęp opisuje, *dlaczego* wybrany temat jest istotny klinicznie i co czytelnik zyska z lektury pracy. Opis zawartości rozdziałów to element struktury, który UMB i WUM dopuszczają, ale powinien zajmować co najwyżej jeden krótki akapit – nie pół strony wypunktowanej listy.

2.1.2 Przegląd piśmiennictwa – struktura kliniczna, nie encyklopedia

Zarówno WUM, jak i Powiślańska Szkoła Wyższa określają, że przegląd piśmiennictwa powinien obejmować dwa do trzech rozdziałów pracy i być spójny z częścią badawczą. Oznacza to, że układ tematyczny rozdziału teoretycznego musi odpowiadać hierarchii problemów pielęgnacyjnych pacjenta opisanego w studium przypadku.

Jeśli piszesz o pacjencie po zawale mięśnia sercowego przygotowującym się do wypisania ze szpitala, Twój przegląd piśmiennictwa powinien kończyć się omówieniem deficytu samoopieki i edukacji pacjenta kardiologicznego – nie szczegółowym opisem leczenia interwencyjnego. Odwrócenie tej logiki – od teorii do praktyki, a nie od teorii do konkretnego pacjenta – to jeden z najczęściej punktowanych błędów w recenzjach.

System Vancouver

Numeryczny system cytowania piśmiennictwa, w którym każda cytowana pozycja otrzymuje kolejny numer w nawiasie kwadratowym lub jako indeks górny. Pozycje w wykazie piśmiennictwa numeruje się w kolejności pierwszego cytowania w tekście – nie alfabetycznie. UMB i WUM wymagają tego systemu dla prac licencjackich z pielęgniarstwa.

Wymogi ilościowe są jednoznaczne: UMB wymaga minimum 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 10 lat. WUM stosuje tę samą granicę dekadową, dopuszczając starsze pozycje wyłącznie z udokumentowanym uzasadnieniem braku nowszych opracowań. PSW wskazuje na piśmiennictwo z

ostatnich 5 lat jako priorytet, z możliwością sięgnięcia do 10 lat wstecz. W praktyce oznacza to, że artykuły z PubMed wydane przed 2014 rokiem wymagają osobnego uzasadnienia przy recenzji w 2024 roku.

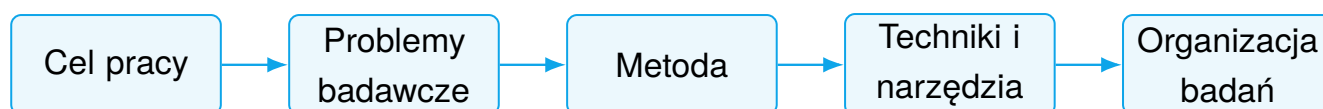
Jak efektywnie przeszukiwać PubMed pod pracę licencjacką

Zacznij od kombinacji MeSH terms: nazwa choroby + „nursing care” lub „nursing intervention”. Ogranicz wyniki filtrem „10 years” i „Polish” lub „English”. Następnie przeszukaj Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) oraz bazę Pielęgniarstwo XXI Wieku – to recenzowane polskie czasopismo branżowe, które recenzenci znają i doceniają. Minimum 10 z 30 wymaganych pozycji powinno pochodzić z artykułów naukowych, nie z podręczników. Podręczniki mogą stanowić tło, ale nie mogą zastąpić badań.

Przegląd piśmiennictwa w pracy pielęgniarskiej musi zawierać cztery obszary tematyczne: definicję i epidemiologię jednostki chorobowej, charakterystykę kliniczną (objawy, diagnostyka, leczenie, powikłania), udział pielęgniarki w realizacji świadczeń zdrowotnych oraz realizację funkcji zawodowych w tym zakresie. Ta ostatnia pozycja jest najczęściej pomijana – a to właśnie ona uzasadnia sens pisania pracy pielęgniarskiej zamiast lekarskiej.

2.1.3 Rozdział metodologiczny – precyzja, nie biurokracja

Rozdział metodologiczny to 1–2 strony, które decydują o tym, czy praca ma charakter naukowy czy wyłącznie opisowy. Każde zdanie zapisuje się w formie bezosobowej – zasada obowiązuje na wszystkich uczelniach objętych tym omówieniem, bez wyjątków.



Cel pracy formułuje się w czasie przeszłym, w formie twierdzenia. Żaden prawidłowy cel pracy licencjackiej z pielęgniarstwa nie zaczyna się od słów „Celem pracy jest sprawdzenie...” ani „Praca ma na celu opisanie...”. Poprawne wzorcowe sformułowanie to: „**Celem pracy było określenie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta z [rozpoznanie], przebywającego w [miejscu] i [sytuacja kliniczna].**”

Problemy badawcze formułuje się jako pytania – nie twierdzenia. Zaczynają się od: „Jakie problemy pielęgnacyjne...”, „W jakim stopniu...”, „Jaka jest specyfika...”. Trzy do czterech pytań badawczych to optimum dla pracy licencjackiej – więcej rozmywa fokus.

Metodą badawczą jest zawsze **metoda indywidualnego przypadku**. Techniki to: wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej, pomiar parametrów życiowych i badanie fizykalne. Narzędzia to konkretne instrumenty: kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego, historia choroby,

Tabela 2.1: Poprawne i niepoprawne sformułowania celu pracy licencjackiej z pielęgniarstwa

Ocena	Sformułowanie celu
Poprawne	Celem pracy było określenie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej, przebywającego w oddziale chirurgicznym i przygotowywanego do amputacji kończyny.
Poprawne	Celem pracy było rozpoznanie deficytu samoopieki u pacjenta po zawale mięśnia sercowego wypisanego do środowiska domowego.
Niepoprawne	Celem pracy jest opisanie choroby nadciśnieniowej i roli pielęgniarki.
Niepoprawne	W pracy chcę pokazać, jak wygląda opieka nad pacjentem z cukrzycą.
Niepoprawne	Praca dotyczy problemów pielęgnacyjnych pacjentów onkologicznych.

wyniki badań laboratoryjnych, skale kliniczne. Zamieszczenie w tej części skali Barthel lub NRS bez wskazania, że rzeczywiście została zastosowana u opisywanego pacjenta, to błąd, który recenzent wyłapie natychmiast.

Metodologia jako mapa, nie formalność

Rozdział metodologiczny nie jest formularzem do wypełnienia. Jest precyzyjnym opisem tego, skąd pochodzą informacje o pacjencie i w jaki sposób zostały przetworzone w diagnozy pielęgniarские. Recenzent z UMW ocenia „wykorzystanie metod i technik badawczych” jako jedno z 12 kryteriów – warte do 3 punktów. To różnica między oceną 3,5 a 4,0 na tym jednym kryterium.

2.1.4 Wybór i sformułowanie tematu – jak nie zacząć od błędu

Wybór tematu to pierwsza decyzja, która rzutuje na całą pracę. W pielęgniarstwie temat musi spełniać trzy warunki jednocześnie: odnosić się do **konkretnej jednostki chorobowej**, wskazywać **oddział lub środowisko opieki** oraz zawierać **perspektywę pielęgniarскую** – nie lekarską.

Przy doborze jednostki chorobowej kieruj się dostępnością przypadku. Najczęściej wybierane specjalizacje to: chirurgia ogólna (np. opieka nad pacjentem po resekcji jelita grubego), interna (np. pielęgnowanie chorego z niewydolnością serca w klasie NYHA III), neurologia (np. opieka nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu) oraz pediatria (np. opieka pielęgniarская nad dzieckiem z astmą oskrzelową). Wybieraj oddział, w którym odbywałaś praktyki – masz wtedy realny dostęp do dokumentacji i możliwość zebrania wywiadu.

Najczęstszy błąd w tytule

Unikaj tytułów w stylu: „Cukrzyca typu 2 – charakterystyka choroby”. To tytuł pracy medycznej, nie pielęgniarskiej. Poprawna forma to: „Opieka pielęgniarская nad pacjentem z cukrzycą typu 2 leczonym na oddziale chorób wewnętrznych – studium przypadku”. Tytuł musi zawierać słowo „opieka” lub „pielęgnowanie” oraz określenie miejsca lub kontekstu klinicznego.

Długość tytułu nie powinna przekraczać **15 słów** – dłuższe tytuły są zazwyczaj symptomem braku precyzji. Zanim złożysz propozycję promotorowi, sprawdź w uczelnianej bazie prac dyplomowych, czy podobny temat nie był już realizowany w ciągu ostatnich trzech lat – promotorzy zwracają na to uwagę podczas zatwierdzania.

Szablon tytułu

„Opieka pielęgniarska nad pacjentem z [jednostka chorobowa] [hospitalizowanym/leczonym] na oddziale [nazwa oddziału] – studium przypadku” – ten schemat spełnia wymogi formalne większości uczelni medycznych w Polsce.

2.2 Opis przypadku i diagnoza pielęgniarska – jak zebrać dane i przełożyć je na plan opieki

16

elementów obejmuje prawidłowy wywiad pielęgniarski według wytycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej i WUM

Opis przypadku to centralny element pracy kazuistycznej – i jednocześnie ta jej część, która najlepiej odróżnia pracę myślącego klinicysty od pracy sklejonej z podręcznikowych szablonów. Dwa do trzech stron to zalecana objętość (WUM, PSW) – tyle wystarczy, by przedstawić pełny obraz pacjenta bez zbędnego rozbudowywania historii choroby w stylu narracji literackiej.

2.2.1 Wywiad pielęgniarski – co zbierać i w jakiej kolejności

Wywiad pielęgniarski w pracy licencjackiej musi być ustrukturyzowany. PSW i WUM wymieniają dokładnie te same elementy obowiązkowe. Poniżej wyliczone są dane, które muszą pojawić się w opisie przypadku:

- inicjały pacjenta (nigdy pełne imię i nazwisko – wymóg anonimizacji),
- data urodzenia i wiek, płeć, stan cywilny,
- aktywność zawodowa i warunki socjalno-bytowe,
- data przyjęcia i rozpoznanie lekarskie,
- historia choroby: przebyte choroby, pobyty szpitalne, zabiegi, urazy,
- aktualny stan ogólny: temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze, masa ciała, wzrost,
- stosowane leki i choroby współistniejące,
- wywiad rodzinny, w tym choroby genetycznie uwarunkowane,

- stan wiedzy i umiejętności pacjenta w zakresie samoopieki.

Kluczowy błąd polega na tym, że studenci zbierają te dane, ale opisują je narracyjnie – strona za stroną tekstu ciągłego, bez wyraźnej struktury. Recenzent, który czyta kilkanaście prac, potrzebuje móc szybko odnaleźć konkretną informację. Tabela demograficzna na wstępie opisu przypadku z podstawowymi danymi pacjenta (wiek, płeć, rozpoznanie, miejsce hospitalizacji, parametry życiowe przy przyjęciu) to rozwiązanie, które wygląda profesjonalnie i ułatwia czytanie.

2.2.2 Skale kliniczne – narzędzia, które legitymizują ocenę

Skale kliniczne pełnią w pracy licencjackiej podwójną funkcję: są narzędziami diagnostycznymi uzasadniającymi diagnozy pielęgniarstwa i dowodem na to, że student posługuje się standaryzowanymi metodami oceny stanu pacjenta.

Tabela 2.2: Skale kliniczne stosowane w pracy licencjackiej z pielęgniarstwa – zakres i zastosowanie

Skala	Co ocenia	Typowe zastosowanie
Barthel (ADL)	Samodzielność w czynnościach dnia codziennego	Pacjenci po udarze, ortopedyczni, geriatryczni
Norton	Ryzyko powstania odleżyn	Każdy pacjent z ograniczoną mobilnością
NRS / VAS	Natężenie bólu (0–10)	Pacjenci z bólem ostrym i przewlekłym
GCS	Poziom świadomości	Pacjenci neurologiczni, po urazach głowy
MMSE	Funkcje poznawcze	Pacjenci geriatryczni, psychiatryczni

Ważne: skala musi być zastosowana wobec opisywanego pacjenta i wynik musi pojawić się zarówno w rozdziale metodologicznym (jako narzędzie badawcze), jak i w opisie przypadku (jako konkretna wartość). Napisanie „zastosowano skalę Barthel” bez podania, że pacjent uzyskał 45 punktów, czyni opis niekompletnym. Wynik skali jest punktem wyjścia do diagnozy pielęgniarstwa – bez niego diagnoza zawisa w powietrzu.

2.2.3 Od danych do diagnozy pielęgniarstwa – logika, nie intuicja

Diagnoza pielęgniarstwa to nie opis objawów. To sformułowany problem pacjenta wymagający indywidualizowanej interwencji pielęgniarstwa. To rozróżnienie – między objawem a diagnozą – jest jednym z kryteriów ocenianych zarówno przez promotora, jak i recenzenta w regulaminie UMW.

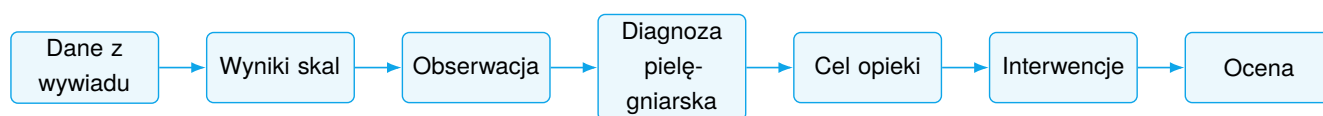
Diagnoza pielęgniarstwa

Sformułowany problem kliniczny lub zdrowotny pacjenta, który leży w kompetencjach pielęgniarki i wymaga zaplanowanej interwencji. Diagnoza pielęgniarstwa nie jest tożsama z rozpoznaniem

lekarskim – opisuje odpowiedź pacjenta na chorobę, nie jej przyczynę. Podstawą do jej postawienia jest analiza danych z wywiadu, obserwacji i narzędzi oceny.

Typowy błąd: student pisze „diagnoza pielęgniarska: nadciśnienie tętnicze”. To rozpoznanie lekarskie, nie diagnoza pielęgniarska. Prawidłowa diagnoza brzmi: „Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych związane z wartościami ciśnienia tętniczego 165/100 mmHg i nieregularnym stosowaniem leków hipotensyjnych”. Różnica polega na tym, że druga wersja zawiera informację o tym, *czego* pielęgniarka się obawia i *dla czego* – i to właśnie stanowi podstawę do zaplanowania interwencji.

Hierarchia diagnoz pielęgniarskich ma znaczenie. WUM, PSW i UMW zgodnie wskazują, że problemy należy wymieniać według hierarchii ważności dla życia i zdrowia pacjenta – nie alfabetycznie ani chronologicznie. Zagrożenie niedotlenieniem organizmu zawsze poprzedza deficyt wiedzy na temat diety, nawet jeśli ten drugi pojawił się w wywiadzie wcześniej.



2.2.4 Plan opieki pielęgniarskiej – tabela, która musi działać

Plan opieki to operacyjny rdzeń pracy kazuistycznej. Każda z uczelni (WUM, PSW, UMB, UMW) wymaga, by plan opieki zawierał trzy kolumny: diagnozę pielęgniarską, cel opieki i zastosowane interwencje pielęgniarskie. Część uczelni dodaje czwartą kolumnę: ocenę realizacji celu.

Cel opieki musi być **mierzalny i osiągalny w określonym czasie**. „Poprawa stanu pacjenta” to nie cel – to życzenie. „Zmniejszenie natężenia bólu z 7 do 3 w skali NRS w ciągu 24 godzin od wdrożenia interwencji” to cel. Różnica jest fundamentalna dla każdego, kto rozumie proces pielęgnowania.

Interwencje pielęgniarskie zapisuje się jako konkretne działania – z podmiotem („pielęgniarka”), czasownikiem czynnym i, tam gdzie to możliwe, częstotliwością wykonania. „Monitorowanie ciśnienia tętniczego co 4 godziny”, „edukacja pacjenta w zakresie techniki inhalacji przed wypisem”, „ocena ryzyka odleżyn skalą Norton przy każdej zmianie opatrunku” – takie zapisy mają wartość kliniczną. „Zapewnienie odpowiedniej opieki” – nie ma żadnej.

Diagnoza i interwencja – fragment planu opieki dla pacjenta z POChP

Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko niedotlenienia związane z dusznością spoczynkową i saturacją SpO₂ wynoszącą 88% przy przyjęciu na oddział.

Cel opieki: Utrzymanie saturacji krwi tlenem na poziomie co najmniej 92% w ciągu 6 godzin od wdrożenia tlenoterapii biernej.

Interwencje pielęgniarские: (1) ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej Fowlera, (2) podanie tlenu przez maskę Venturiego z przepływem 2 l/min zgodnie z zaleceniem lekarskim, (3) monitorowanie SpO₂ pulsoksymetrem co 30 minut, (4) ocena toru oddechowego i częstości oddechów co godzinę, (5) edukacja pacjenta w zakresie techniki oddychania torem przeponowym.

Taki zapis spełnia wymogi formalne UMW, WUM i PSW – zawiera mierzalny cel, konkretne działania z częstotliwością i odwołanie do wyników narzędzi diagnostycznych użytych w badaniu.

Plan opieki jako dowód kompetencji klinicznych

Regulamin dyplomowania UMW ocenia „zdefiniowanie problemów w oparciu o diagnozę pielęgniar-ską” oraz „określenie hierarchii problemów zdrowotnych” jako dwa osobne kryteria – każde warte do 3 punktów. Plan opieki z pięcioma dobrze uzasadnionymi diagnozami pielęgniarскими i mierzalnymi celami zarobi łącznie do 6 punktów na tych dwóch kryteriach. Praca bez hierarchii lub z diagnozami będącymi de facto rozpoznaniem lekarskimi straci je wszystkie.

2.3 Podsumowanie, streszczenia i aneks – elementy, które decydują o końcowej ocenie redakcyjnej

Ostatnie kilka stron pracy licencjackiej z pielęgniarstwa studenci piszą najszybciej – i najgorzej. Podsumowanie traktowane jest jak wymóg formalny do odhaczenia, streszczenie kopiowane z wstępu, a aneks kompletowany w pośpiechu. Tymczasem to właśnie te elementy decydują o końcowej ocenie redakcyjnej – kryterium, które w skali UMW daje do 3 dodatkowych punktów za „poprawność stylistyczną i gramatyczną tekstu” oraz „redakcję przypisów i załączników”.

2.3.1 Podsumowanie – wnioski, nie streszczenie

Podsumowanie to jedyna część pracy, którą recenzent czyta najpierw – przed wstępem, przed rozdziałem metodologicznym. To standard akademicki, który wynika z ograniczonego czasu recenzji. Jeśli podsumowanie jest niejasne lub nie odpowiada na postawione cele i problemy badawcze, recenzent zaczyna lekturę pracy z nastawieniem krytycznym.

Wymagania formalne są jednolite we wszystkich przeanalizowanych uczelniach: podsumowanie musi być **wypunktowane**, formułować wnioski odpowiadające kolejno celowi i problemom badawczym pracy, być zapisane w formie bezosobowej i zawierać wskazówki dla praktyki pielęgniarskiej.

Typowy błąd: podsumowanie jako streszczenie rozdziałów. „W rozdziale pierwszym omówiono..., w rozdziale drugim przedstawiono...” – to spis treści, nie wnioski. Wniosek to sformułowanie

tego, co wynika z przeprowadzonego studium przypadku i jak to się przekłada na praktykę. „U opisywanego pacjenta zidentyfikowano pięć priorytetowych problemów pielęgnacyjnych, z których najistotniejsze z perspektywy zagrożenia życia stanowiło ryzyko niedotlenienia. Wdrożone interwencje pozwoliły utrzymać saturację powyżej 92% w ciągu pierwszych 12 godzin hospitalizacji” – to wniosek, który ma wartość kliniczną.

2.3.2 Streszczenia – dwa języki, jeden standard

WUM wymaga streszczenia do 300 słów z kluczowymi słowami. UMB wymaga streszczenia w języku polskim i angielskim, zamkniętego na jednej stronie formatu A4. UMW i PSW wskazują streszczenie dwujęzyczne jako element standardowy. We wszystkich przypadkach streszczenie jest samodzielnym tekstem – nie skrótem wstępu, nie zbiorem cytatów z innych rozdziałów.

Tabela 2.3: Porównanie wymagań dotyczących podsumowania i streszczeń w wybranych uczelniach

Wymóg	WUM	UMB	UMW
Forma podsumowania	Wypunktowane wnioski	Wypunktowane, jasne	Wnioski z odniesieniem do celu
Streszczenie PL	Tak, max 300 słów	Tak, max 1 strona	Tak
Streszczenie EN	Zalecane	Wymagane	Wymagane
Słowa kluczowe	3–5	Nie określono	Nie określono
Cytaty w streszczeniu	Niedozwolone	Niedozwolone	Niedozwolone

Streszczenie musi zawierać pięć elementów: krótkie wprowadzenie w temat, cel pracy (dosłownie powtórzony z rozdziału metodologicznego), charakterystykę pacjenta i zastosowanych metod, skrót wyników (diagnozy pielęgniarstwa i efekty interwencji) oraz wnioski. Anglojęzyczna wersja streszczenia jest tłumaczeniem polskiego – nie parafrazą. Studenci, którzy piszą angielskie streszczenie od nowa, często nieświadomie zmieniają brzmienie celu pracy, co powoduje niespójność.

Jak uniknąć niespójności między streszczeniem a treścią pracy

Napisz streszczenie *po* ukończeniu całej pracy – nie przed. Następnie porównaj cel pracy w streszczeniu z celem w rozdziale metodologicznym: sformułowania muszą być identyczne lub różnić się wyłącznie stylistycznie. To samo dotyczy wniosków: każdy wniosek ze streszczenia musi mieć odpowiednik w podsumowaniu. Recenzent, który znajdzie rozbieżność, traci zaufanie do rzetelności całej pracy.

2.3.3 Aneks – dokumentacja, nie śmietnik

Aneks jest zbiorem materiałów, których umieszczenie w treści głównej zaburzyłoby proporcje pracy lub utrudniło jej czytanie. UMB definiuje to precyzyjnie: aneks może zawierać standardy

postępowania, kserokopie aktów prawnych, wzory kwestionariuszy. WUM dodaje: narzędzia badawcze, karty obserwacji, skale kliniczne w pełnej wersji, wyniki badań laboratoryjnych (bez możliwości identyfikacji pacjenta).

Każdy załącznik w aneksie musi mieć numer i być przywołany w tekście głównym – w nawiasie kwadratowym, np. [Aneks 1]. Jeśli w tekście nie ma odesłania do danego załącznika, nie powinno go być w aneksie. UMW wymaga tego mechanizmu odesłań jako warunku formalnego.

Anonimizacja danych pacjenta – obowiązek, nie zalecenie

Każdy dokument w aneksie, który zawiera dane pacjenta (wyniki badań, fragmenty historii choroby, karty obserwacji), musi być zanonimizowany: imię, nazwisko, PESEL, adres – wszystkie dane identyfikujące muszą być zamazane lub usunięte. Dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej. PSW i WUM wskazują wprost, że zamieszczenie zdjęć pacjenta wymaga jego pisemnej zgody i opinii uczelnianej Komisji Bioetycznej. Niedopełnienie obowiązku anonimizacji to naruszenie tajemnicy zawodowej – z konsekwencjami wykraczającymi poza ocenę akademicką.

2.3.4 Różnice między uczelniami – praktyczny przegląd

Regulaminy PSW, WUM, UMB i UMW zgadzają się w kwestiach kluczowych: forma kazuistyczna, format A4, czcionka Times New Roman 12 pt, interlinia 1,5, marginesy z szerszym lewym (3,5 cm). Różnią się w detalach, które przy składaniu pracy mają znaczenie.

UMB wymaga okładki sztywnej i stron ponumerowanych w prawym dolnym rogu. WUM wymaga dwóch egzemplarzy w różnych oprawach (miękką i twardą) i wersji elektronicznej na płycie CD – wymóg, który w 2024 roku brzmi anachronicznie, ale figuruje w regulaminie i należy go spełnić. UMW wymaga pliku w formacie DOC lub DOCX i PDF na nośniku elektronicznym, z pisemnym oświadczeniem o identyczności obu wersji. PSW przyjmuje pracę wyłącznie w formacie PDF przesłanym mailem na adres odpowiedniego dziekanatu, z dołączonym oświadczeniem podpisanym elektronicznie przez ePUAP.

12

kryteriów ocenia recenzent pracy dyplomowej według regulaminu UMW – każde warte do 3 punktów, maksimum 36

Ta liczba powinna być dla każdego studenta mapą pracy. Recenzent UMW ocenia kolejno: sformułowanie przedmiotu i problemu badawczego, cel pracy, metody i techniki, diagnozę pielęgniarską, hierarchię problemów, zasadność problemów, dobór literatury, zakres źródeł empirycznych, trafność wniosków, poprawność stylistyczną, redakcję przypisów i załączników oraz poprawność spisu treści i piśmiennictwa. Każde kryterium, które student zaniedbuje, to

utracony punkt – a różnica między oceną „dobry” a „ponad dobry” u recenzenta wynosi zaledwie 6 punktów na 36.

Ostatnie strony pracy – ostatnia szansa na punkty

Podsumowanie, streszczenia i aneks to elementy, które student może dopracować do ostatniej chwili – bez konieczności konsultacji z promotorem, bez dostępu do pacjenta, bez biblioteki. To czysta robota redakcyjna: zgodność wniosków z celem, poprawność językowa, kompletność odesłań do aneksu, identyczność polskiej i angielskiej wersji streszczenia. Studenci, którzy poświęcają tym elementom po jednej roboczej godzinie każdemu, regularnie podnoszą końcową ocenę redakcyjną o pół stopnia – co przy wąskich widełkach między kategoriami ocen ma realny wpływ na wynik dyplomu.

2.3.5 Piśmiennictwo – format, który musi być bez zarzutu

Wykaz piśmiennictwa to element pracy, który recenzent sprawdza mechanicznie – i właśnie dlatego błędy formalne są tu szczególnie kosztowne. Ocena „poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji danych” figuruje jako osobne kryterium zarówno u promotora, jak i recenzenta w regulaminie UMW. Przy systemie Vancouver każda pozycja musi być przywołana w tekście w kolejności cytowania. Jeśli w wykazie pojawia się pozycja, której nie ma w tekście – naruszasz zasadę cytowania. Jeśli w tekście pojawia się odesłanie do numeru, którego nie ma w wykazie – to błąd formalny, który może skutkować odesłaniem pracy do poprawy przed dopuszczeniem do obrony.

Trzy kontrole piśmiennictwa przed złożeniem pracy

Przed wysłaniem pliku do dziekanatu wykonaj trzy sprawdzenia: (1) przejdź przez tekst i wypunktuj każdy numer w nawiasie kwadratowym – każdy musi mieć odpowiednik w wykazie; (2) sprawdź, czy każda pozycja w wykazie pojawia się przynajmniej raz w tekście – pozycje bez cytowania usuń lub uzupełnij brakujące odesłania; (3) zweryfikuj rok wydania każdej pozycji – przy wymogu „ostatnie 10 lat” artykuł z 2013 roku w pracy obronionej w 2024 roku wymaga pisemnego uzasadnienia lub zamiany na nowsze źródło. Menedżer bibliografii Zotero z wtyczką do Worda automatyzuje punkty (1) i (2) i eliminuje błędy numeracji przy dodawaniu lub usuwaniu źródeł w trakcie pisania.

Format zapisu pozycji bibliograficznych różni się w zależności od rodzaju źródła. UMB podaje wzorcowe zapisy dla trzech najczęstszych typów: artykułu w czasopiśmie naukowym (nazwisko, inicjał imienia, tytuł, pełna nazwa czasopisma, rok, tom, strony), rozdziału w książce (nazwisko autora rozdziału, tytuł rozdziału, tytuł książki, redaktor, wydawnictwo, rok, strony) oraz całej książki (nazwisko, inicjał imienia, tytuł, wydawnictwo, rok – bez podawania zakresu stron). Strony internetowe dopuszczalne są wyłącznie z serwisów recenzowanych czasopism, organizacji międzynarodowych (WHO, ECDC) lub agencji rządowych (GUS, MZ, NFZ) – z obowiązkową datą pobrania. Ogólnodostępne portale medyczne, blogi branżowe i serwisy encyklopedyczne nie kwalifikują się jako źródła akademickie.

2.3.6 Spisy tabel, rycin i fotografii – porządek formalny

UMB wymaga trzech osobnych wykazów: tabel, rycin i fotografii. WUM grupuje ryciny i tabele w jednym spisie, dopuszczając fotografię jako podkategorię rycin. UMW nie precyzuje odrębności wykazów, ale wskazuje na automatyczny spis jako wymóg edytorski.

Tabele i ryciny bez źródła – błąd plagiatu

Każda tabela i każda rycina skopiowana z zewnętrznego źródła – nawet jeśli zostanie przerobiona graficznie – wymaga adnotacji o źródle pod spodem. Jedynym wyjątkiem jest materiał stworzony samodzielnie przez autora pracy, który można opisać jako „opracowanie własne”. WUM i AWF w swoich regulaminach precyzują wprost: jeśli tabela *inspiruje się* innym źródłem, należy podać „opracowanie własne na podstawie: [pełne źródło z numerem strony]”. Brak tej adnotacji kwalifikuje się jako nieuprawnione przywłaszczenie cudzej pracy – niezależnie od tego, jak dalece zmodyfikowano oryginalną grafikę.

Numeracja tabel i rycin musi być ciągła i niezależna – tabele numeruje się osobno od rycin, cyfry arabskie, od numeru 1. Tytuł tabeli umieszcza się *nad* tabelą; tytuł ryciny i fotografii – *pod* nimi. To zasada obowiązująca we wszystkich regulaminach bez wyjątku. Studenci, którzy umieszczają podpis tabeli pod nią, tracą punkt w kryterium redakcji graficznej prezentacji danych.

2.3.7 Oświadczenia i strona tytułowa – formalności z konsekwencjami

Strona tytułowa nie jest numerowana – to zasada wspólna dla WUM, UMB, PSW i UMW. Musi zawierać: pełną nazwę uczelni i wydziału, imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł pracy w języku polskim (UMW i AWF wymagają również tytułu w języku angielskim), informację o charakterze pracy („Praca licencjacka”), nazwę jednostki organizacyjnej, w której praca powstała, oraz imię, nazwisko i tytuł naukowy promotora.

PSW wymaga złożenia oświadczenia studenta podpisanego elektronicznie przez profil zaufany ePUAP – w formacie PDF, jako osobny plik dołączony do pracy. To wymóg, który studenci odkrywają zbyt późno: założenie profilu zaufanego i podpisanie dokumentu elektronicznego zajmuje kilka dni, jeśli robi się to po raz pierwszy. WUM wymaga oświadczenia wydrukowanego, podpisanego ręcznie i włączonego do pracy jako druga strona – po zeskanowaniu.

Harmonogram ostatnich tygodni przed złożeniem – co i kiedy

Typowy student składa pracę pod koniec maja semestru VI. Cztery tygodnie wcześniej: ostatnia konsultacja z promotorem, wprowadzenie poprawek do planu opieki i podsumowania. Trzy tygodnie wcześniej: finalna korekta piśmiennictwa z weryfikacją każdego numeru cytowania, przygotowanie aneksu z zanonimizowanymi dokumentami. Dwa tygodnie wcześniej: złożenie pliku w systemie antyplagiatowym i oczekiwanie na raport – UMW i PSW wymagają pozytywnego wyniku przed dopuszczeniem do dalszego postępowania. Jeden tydzień wcześniej: przygotowanie oświadczeń,

skompletowanie wymaganej liczby egzemplarzy i nośników elektronicznych. Studenci, którzy zaczynają procedurę antyplagiatową w przeddzień terminu, ryzykują opóźnienie obrony o cały rok akademicki – nie semestr, lecz rok, bo kolejny termin obrony przypada dopiero w następnym cyklu dyplomowania.

Regulamin dyplomowania UMW z roku akademickiego 2025/2026 precyzuje, że w przypadku niezłożenia pracy w terminie dziekan skreśla studenta z listy studentów. Odwołanie do rektora jest możliwe w ciągu 14 dni, ale decyzja rektora jest ostateczna. Żaden z pozostałych regulaminów nie formułuje tej konsekwencji tak ostro – co oznacza, że UMW jest uczelnią, gdzie opóźnienie formalne niesie najcięższe bezpośrednie skutki.

Anatomia pracy to mapa punktów do zdobycia

Każdy element pracy licencjackiej z pielęgniarstwa – od sformułowania celu po format zapisu ostatniej pozycji bibliograficznej – odpowiada konkretnemu kryterium oceny promotora lub recenzenta. Nie ma tu miejsca na przypadek ani na zasadę „jakoś to będzie”. Student, który traktuje tę mapę poważnie i weryfikuje każdy element przed złożeniem pracy, eliminuje błędy, które w innym przypadku kosztują go od pół do jednego stopnia na skali ocen. A ponieważ ocena pracy wchodzi do średniej ważonej decydującej o wyróżnieniu na dyplomie, różnica między 4,0 a 4,5 u recenzenta to różnica między dyplomem z wyróżnieniem a dyplomem bez niego.

Rozdział 3.

Egzamin dyplomowy z pielęgniarstwa – obrona pracy, test MCQ i OSCE jako system naczyń połączonych

Praca licencjacka to nie cel sam w sobie – to fundament, na którym komisja egzaminacyjna buduje ocenę Twojej gotowości do samodzielnej praktyki klinicznej.

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo jest czymś strukturalnie innym niż egzamin dyplomowy na większości kierunków humanistycznych czy społecznych. Nie chodzi tu wyłącznie o to, czy student napisał poprawną pracę i czy potrafi ją obronić. Trzy odrębne elementy – test wiedzy kierunkowej MCQ, egzamin praktyczny OSCE oraz obrona pracy dyplomowej – tworzą jeden zintegrowany system oceny. Pozytywna ocena z każdego z nich jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa. Negatywna choćby z jednego blokuje całość, niezależnie od wyników pozostałych.

Regulamin dyplomowania Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2025/2026, precyzuje tę sekwencję jednoznacznie: najpierw test MCQ, następnie OSCE, a dopiero po uzyskaniu ocen co najmniej dostatecznych z obu tych części – obrona pracy. Każdy, kto przygotowuje się do tych egzaminów jako do trzech niezależnych wydarzeń, popełnia błąd, który może go kosztować miesiące opóźnień.

3.1 Test MCQ – 100 pytań, 13 dziedzin, 60% próg zaliczenia: co musisz wiedzieć przed salą egzaminacyjną

60

pytań poprawnych to absolutne minimum, by przejść do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego

Test składa się ze 100 pytań zamkniętych w formacie MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa spośród czterech. Masz na to 100 minut, czyli średnio jedną minutę na pytanie. Próg zaliczenia wynosi 60 punktów. Za błędną odpowiedź nie tracisz punktów – tylko nie zyskujesz. To ważne w strategii podejścia do pytań, przy których masz wątpliwości: zawsze zaznacz cokolwiek.

Rozkład pytań według regulaminu UMW 2025/2026 wygląda następująco:

Tabela 3.1: Rozkład pytań w teście MCQ egzaminu dyplomowego licencjackiego (UMW 2025/2026)

Dziedzina	Liczba pytań
Podstawy pielęgniarstwa	10
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne	10
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne	10
Pediatrya i pielęgniarstwo pediatryczne	10
Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia	10
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne	10
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne	10
Podstawowa opieka zdrowotna	5
Promocja zdrowia	5
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarstwa	5
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej	5
Ginekologia i położnictwo, pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze	5
Geriatrya i pielęgniarstwo geriatryczne	5
Łącznie	100

Siedem dziedzin po 10 pytań odpowiada za 70% testu. To tu rozgrywa się egzamin. Dziedziny pięciopytaniowe mają mniejszy wpływ na wynik końcowy – nawet pełen błąd w geriatry to strata 5 punktów, czyli 5% wyniku. Dla porównania: błąd na poziomie 6 z 10 pytań z pielęgniarstwa psychiatrycznego to już 6 punktów straty w jednej dziedzinie.

Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne – dziedziny z najwyższym ryzykiem

Studenci pielęgniarstwa spędzają nieproporcjonalnie mało czasu na praktykach psychiatrycznych w porównaniu z internistycznymi czy chirurgicznymi. To przekłada się na słabsze przygotowanie

do pytań z tej dziedziny w teście MCQ. Obie dziedziny odpowiadają łącznie za 20 pytań – jedną piątą testu. Ignorowanie ich w powtórcie to jeden z najczęstszych powodów, dla których studenci nie przekraczają progu 60%.

Temat Twojej pracy licencjackiej ma tu znaczenie, którego wielu studentów nie docenia. Jeśli pisałeś pracę o pacjencie z przewlekłą niewydolnością serca, to pytania z pielęgniarstwa internistycznego i kardiologicznego są dla Ciebie znacznie łatwiejsze – przerobiłeś je dogłębnie, zbierając wywiad i pisząc plan opieki. To samo dotyczy pytań z podstaw pielęgniarstwa: diagnoza pielęgniarska, hierarchia problemów, interwencje pielęgniarskie – mechanizmy, które ćwiczyłeś, pisząc rozdział czwarty pracy, pojawiają się w teście jako pytania o definicje i zasady postępowania.

Jak zintegrować powtórkę z pisanem pracy

Kiedy piszesz rozdział teoretyczny pracy, twórz równolegle kartę powtórkową: definicja jednostki chorobowej, epidemiologia, diagnostyka, leczenie farmakologiczne i nefarmakologiczne, specyficzne interwencje pielęgniarskie. Ta sama karta posłuży jako materiał do nauki przed testem MCQ. Dwie godziny przy pisaniu pracy mogą zastąpić cztery godziny odrębnej nauki przed egzaminem.

Na sali egzaminacyjnej obowiązują zasady, których naruszenie kończy egzamin natychmiast: zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych, konieczność parafowania poprawionych odpowiedzi, dwukrotne upomnienie za brak samodzielności oznacza zakończenie egzaminu z oceną niedostateczną. Student powinien stawić się 15 minut przed rozpoczęciem z dowodem osobistym lub legitymacją i długopisem. Wyniki podawane są najpóźniej następnego dnia.

Test MCQ nagradza wiedzę kliniczną, nie encyklopedyczną

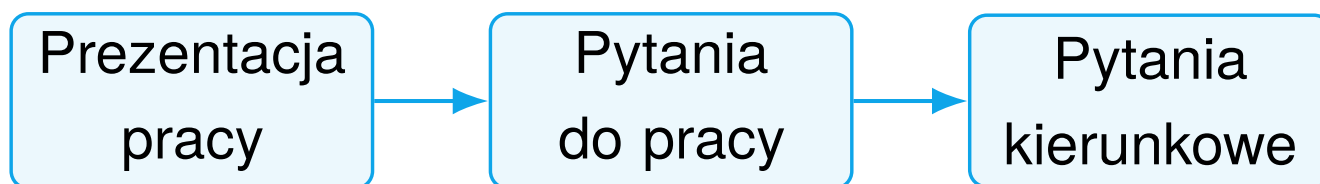
Siedem dziedzin po 10 pytań stanowi 70% testu. Praca licencjacka pisana rzetelnie – z pełnym przeglądem piśmiennictwa i szczegółowym planem opieki – jest najlepszym przygotowaniem do tych pytań. Student, który pisząc pracę, naprawdę rozumiał patofizjologię choroby i mechanizm interwencji pielęgniarskich, wchodzi na salę testową z przewagą.

3.2 Obrona pracy przed komisją – prezentacja, pytania promotora i recenzenta, pytania kierunkowe

Komisja egzaminacyjna

Trzyosobowy skład powoływany przez dziekana: przewodniczący (co najmniej doktor), promotor i recenzent. Co najmniej jedna osoba musi posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. To nie panel akademicki – to weryfikacja gotowości zawodowej.

Obrona ma trzy wyraźne fazy i każda z nich jest oceniana osobno. Znajomość tej struktury przed wejściem na salę eliminuje większość stresu wynikającego z niepewności, co się wydarzy.



3.2.1 Faza pierwsza: prezentacja

Prezentacja obejmuje tytuł pracy, założenia, najistotniejsze wyniki badań i wnioski. Regulamin dopuszcza prezentację multimedialną. W praktyce, przygotowanie 8–12 slajdów w PowerPoint lub Keynote to standard na większości uczelni medycznych. Slajdy powinny być narzędziem nawigacji dla komisji, nie ściągawką dla studenta.

Najczęstszy błąd prezentacji: student opisuje chorobę zamiast opisywać pacjenta i opiekę. Komisja zna patofizjologię niewydolności serca – nie po to studiowała. Chce zobaczyć, czy student rozumie, jak ta patofizjologia przełożyła się na konkretne problemy pielęgnacyjne konkretnej osoby, i jak zaplanował działania, by te problemy rozwiązać.

Jak wygląda dobra prezentacja obrony – scenariusz typowy

Wyobraź sobie studenta, który opisywał pacjenta po udarze niedokrwionym mózgu przebywającego w oddziale neurologicznym. Dobra prezentacja zaczyna się od jednego zdania o pacjencie: wiek, rozpoznanie, kontekst hospitalizacji. Następnie trzy lub cztery główne problemy pielęgnacyjne ze zdefiniowaną hierarchią. Potem – kluczowe interwencje z uzasadnieniem klinicznym i ocena wyników. Na końcu wnioski dla praktyki. Całość trwa 7–10 minut. Komisja wie, że student rozumie proces pielęgnowania, a nie tylko opisał chorobę z podręcznika.

3.2.2 Faza druga: pytania do pracy

Promotor i recenzent zadają pytania bezpośrednio związane z pracą. Promotor zna pracę od początku i zazwyczaj pyta o decyzje metodologiczne: dlaczego wybrałeś tę hierarchię problemów, dlaczego zdecydowałeś się na daną skalę oceny, dlaczego opis przypadku trwa dwa tygodnie, a nie jeden. Recenzent pyta z pozycji osoby, która przeczytała pracę raz i oceniła ją krytycznie – jego pytania dotyczą słabych stron, które wytknął w recenzji.

Strategia przygotowania: przeczytaj recenzję uważnie. Każde słabe miejsce wskazane przez recenzenta to potencjalne pytanie. Przygotuj krótką, merytoryczną odpowiedź na każde z nich – nie obronę, lecz wyjaśnienie. „Rzeczywiście, próba badawcza jest jednostkowa, co ogranicza możli-

wość generalizacji wyników. Metoda studium przypadku zakłada głębię analizy indywidualnej, nie reprezentatywność próby” – to zdanie wystarczy.

3.2.3 Faza trzecia: pytania kierunkowe

To element, który studenci często lekceważą, koncentrując się na przygotowaniu do pytań o pracę. Regulamin UMW z 2025/2026 precyzuje: trzy pytania z zakresu efektów uczenia się studiów I stopnia, każde warte 10 punktów, łącznie 30 punktów. Ocena bardzo dobra wymaga 28–30 punktów.

Tabela 3.2: Skala ocen za odpowiedzi na pytania kierunkowe w obronie (UMW 2025/2026)

Punkty	Ocena słowna	Ocena liczbowa
30–28	Bardzo dobry	5,0
27–25	Ponad dobry	4,5
24–22	Dobry	4,0
21–19	Dość dobry	3,5
18–15	Dostateczny	3,0
14–0	Niedostateczny	2,0

Pytania kierunkowe dotyczą zagadnień z całego programu studiów. Typowe obszary to: etyka zawodowa, zasady zarządzania opieką, farmakologia stosowana w pielęgniarstwie, postępowanie w stanach zagrożenia życia, prawo wykonywania zawodu. Najlepsza strategia przygotowania: wróć do zagadnień z dziedzin, które oceniłeś jako najsłabiej opanowane w teście MCQ – te same obszary zwykle pojawiają się w pytaniach kierunkowych.

Obrona to rozmowa kliniczna, nie egzamin ustny z teorii

Komisja egzaminacyjna chce potwierdzić, że student potrafi myśleć jak pielęgniarka – definiować problemy, hierarchizować je, planować działania i oceniać ich skuteczność. Odpowiedzi na pytania do pracy powinny zawsze zakotwiczać się w konkretnym pacjencie opisanym w pracy. Odpowiedzi na pytania kierunkowe – w praktyce klinicznej. Abstrakcyjne odpowiedzi akademickie brzmią pusto, nawet jeśli są technicznie poprawne.

3.3 Egzamin OSCE w Centrum Symulacji – jak temat pracy przekłada się na umiejętności praktyczne oceniane na stacjach

OSCE

Objective Structured Clinical Examination – egzamin składający się z kilku stacji symulacyjnych, na których student wykonuje konkretne procedury lub podejmuje decyzje kliniczne w kontrolowanych warunkach. Każda stacja oceniana jest przez egzaminatora według ustandaryzowanej listy kontrolnej.

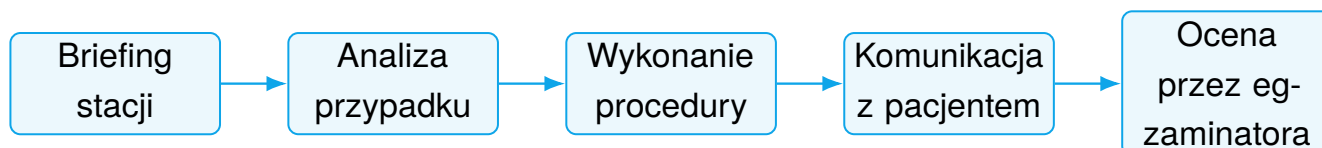
Egzamin OSCE odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej. Student przystępuje do niego po zdaniu testu MCQ – sekwencja jest obowiązkowa i nieodwracalna. Szczegółowy regulamin stacji ogłaszany jest nie później niż osiem tygodni przed terminem egzaminu, co oznacza, że masz ten czas na ukierunkowane ćwiczenia.

Związek między pracą licencjacką a egzaminem OSCE jest głębszy, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Pisząc plan opieki, formułowałeś interwencje pielęgniarские: ocena bólu na skali NRS, pomiar parametrów życiowych, pielęgnacja rany, edukacja pacjenta w zakresie samoopieki, pozycjonowanie chorego, ocena ryzyka odleżyn według skali Norton. To są dokładnie te procedury, które pojawiają się jako zadania na stacjach OSCE.

Przełoż plan opieki z pracy na listę procedur do powtórki

Wróć do rozdziału czwartego swojej pracy – do interwencji pielęgniarских. Każda z nich to potencjalna stacja OSCE. Zrób listę procedur, które wymieniłeś jako działania realizowane przy pacjencie. Następnie sprawdź, czy pamiętasz kolejne kroki każdej z nich. Jeśli pisałeś o pacjencie z cukrzycą i edukowałeś go w zakresie techniki iniekcji insuliny, to właśnie ta procedura – krok po kroku, z zachowaniem aseptyki i weryfikacją miejsca wkłucia – może pojawić się na stacji egzaminacyjnej.

Stacje OSCE w polskich uczelniach medycznych skupiają się na kilku powtarzających się obszarach: ocena stanu pacjenta (w tym badanie fizykalne, pomiar parametrów życiowych, ocena skali bólu), procedury pielęgniarские (zmiana opatrunku, obsługa wkłucia obwodowego, podawanie leków), komunikacja z pacjentem i edukacja zdrowotna, postępowanie w stanach nagłych (RKO, postępowanie wstępne przy utracie przytomności).



Symulator nie reaguje jak pacjent – to pułapka

Studenci, którzy ćwiczą wyłącznie na fantomach w laboratorium umiejętności praktycznych, czasem tracą punkty na stacjach OSCE za element, którego fantomu nie ma: komunikację. Egzaminator ocenia nie tylko to, czy cewnik jest założony technicznie poprawnie, ale czy student poinformował „pacjenta” o procedurze, zapytał o ból, zachował prywatność i sprawdził alergię. Te elementy są osobnymi pozycjami na liście kontrolnej egzaminatora.

Jeśli pisałeś pracę o pacjencie leżącym z ryzykiem odleżyn, przerobiłeś skalę Norton lub Braden, opisałeś zasady zmiany pozycji i pielęgnacji skóry. Na stacji OSCE związanej z profilaktyką przeciwoleżynową masz przewagę: znasz kontekst kliniczny, wiesz, dlaczego te działania mają znaczenie, a nie tylko jak je wykonać. Egzaminatorzy zauważają tę różnicę. Student, który wykonuje procedurę mechanicznie, a student, który uzasadnia każdy krok decyzją kliniczną, uzyskują różne oceny nawet przy identycznej technice.

OSCE weryfikuje to, czego praca nie może pokazać

Praca licencjacka dokumentuje myślenie kliniczne na papierze. OSCE sprawdza, czy to myślenie przekłada się na działanie przy „łóżku pacjenta”. Student, który napisał spójny, uzasadniony plan opieki, ma znacznie ułatwione zadanie na stacjach symulacyjnych – wie, co robi i dlaczego. Centrum Symulacji Medycznej to jedyne miejsce, gdzie komisja może obserwować tę wiedzę w działaniu.

3.4 Zakończenie: trzy egzaminy, jeden cel

Wróciliśmy do punktu wyjścia z rozdziału pierwszego: pielęgniarstwo jest zawodem regulowanym, w którym wiedza teoretyczna ma wartość wyłącznie wtedy, gdy przekłada się na konkretne działanie. Trójczęściowy egzamin dyplomowy – MCQ, OSCE, obrona – to system zaprojektowany właśnie po to, by zweryfikować tę translację.

W rozdziale pierwszym wyjaśniliśmy, dlaczego praca kazuistyczna jest jedyną dopuszczalną metodą – bo tylko studium przypadku sprawdza zdolność do całościowego objęcia opieką niepowtarzalnego człowieka. W rozdziale drugim rozłożyliśmy anatomię tej pracy na czynniki pierwsze, pokazując, że każdy element – od sformułowania diagnozy pielęgniarstwa po ostatnią pozycję bibliograficzną – odpowiada konkretnemu kryterium oceny. W tym rozdziale pokazaliśmy, że praca licencjacka jest nie tylko celem samym w sobie, ale też najlepszym możliwym przygotowaniem do pozostałych dwóch etapów egzaminu.

Student, który napisał rzetelną pracę kazuistyczną – z pogłębionym przeglądem piśmiennictwa, precyzyjnie sformułowanymi diagnozami pielęgniarstwa, hierarchią problemów i uzasadnionymi interwencjami – wchodzi na egzamin z trzema przewagami jednocześnie: zna dziedzinę kliniczną na potrzeby testu MCQ, potrafi obronić swoje decyzje przed komisją, i wie, jak wykonać procedury, które opisał w planie opieki.

Odwrotna sytuacja – student, który napisał pracę pobieżnie, przepisując podręcznik zamiast myśleć klinicznie – traci te przewagi wszystkie naraz.

Jedna praca, trzy egzaminy – to jest właśnie zamysł tego systemu

Praca licencjacka z pielęgniarstwa nie jest dokumentem akademickim pisanym na użytek dziekanatu. Jest dowodem kompetencji klinicznych, który – jeśli napisany rzetelnie – staje się najlepszym możliwym narzędziem do przygotowania się do testu MCQ, obrony i egzaminu OSCE jednocześnie. Zaczynij pisać wcześniej, wybierz pacjenta i jednostkę chorobową, którą naprawdę rozumiesz, i traktuj każdy element pracy jak ćwiczenie kliniczne – nie jak formalność do odfajkowania. To jest różnica między licencjaturą zdobytą i licencjaturą zasłużoną.

Konkretna rada na zakończenie: zanim złożysz pracę w dziekanacie, sprawdź trzy rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, czy każda diagnoza pielęgniarstwa w planie opieki ma przyporządkowaną interwencję i ocenę jej skuteczności – to kryterium oceny zarówno promotora, jak i recenzenta, i pytanie, które niemal na pewno padnie podczas obrony. Po drugie, czy przegląd piśmiennictwa pokrywa dziedziny, z których będziesz pytany w teście MCQ – jeśli nie, dopisz brakujące podrozdziały, zanim praca trafi do recenzji. Po trzecie, czy interwencje pielęgniarstwa opisane w rozdziale czwartym są wystarczająco szczegółowe, by posłużyć jako scenariusz ćwiczenia do stacji OSCE.

Trzy tygodnie przed egzaminem – konkretny plan

Tydzień pierwszy: powtórka z siedmiu dziedzin dziesięciopytaniowego testu MCQ, z kartami powtórkowymi zbudowanymi podczas pisania pracy. Tydzień drugi: ćwiczenia praktyczne w Centrum Symulacji – skup się na procedurach wymienionych w planie opieki Twojej pracy. Tydzień trzeci: przygotowanie prezentacji i odpowiedzi na słabe punkty wskazane przez recenzenta. Trzy tygodnie, trzy etapy – dokładnie jak struktura egzaminu.

Tytuł licencjata pielęgniarstwa nie kończy procesu uczenia się – otwiera dostęp do samodzielnej praktyki klinicznej, specjalizacji i, dla tych, którzy chcą, do studiów II stopnia kończących się tytułem magistra. Regulamin dyplomowania studiów magisterskich, który omówiliśmy przy okazji porównania struktur egzaminacyjnych, nakłada na pracę magisterską wymóg pełnej analizy statystycznej i badania empirycznego – to już zupełnie inna skala wymagań. Ale fundament, który budujesz teraz, pisząc rzetelną pracę kazuistyczną i zdając trójczęściowy egzamin dyplomowy, jest tym samym fundamentem, na którym stoi każda dalsza droga w tym zawodzie.

Ostatnia lekcja tej książki

Każdy element omówiony w tej książce – wybór tematu, struktura pracy, diagnoza pielęgniarstwa, plan opieki, przegląd piśmiennictwa, test MCQ, OSCE, obrona – sprowadza się do jednej umiejętności: myślenia o pacjencie jako o całości, nie jako o zbiorze objawów. To jest kompetencja, której egzamin dyplomowy szuka we wszystkich trzech swoich częściach. Student, który ją posiada, nie musi się bać żadnej z nich.